

HERNIE DIAPHRAGMATIQUE

معزوز عبد الكريم
أستاذ محاضر «أ»
جراحة عامة

I Définition

Hernie Diaphragmatique: Passage permanent ou intermittent d'un ou plusieurs viscères abdominaux dans le thorax par un orifice diaphragmatique anormal

- ☐ Orifice congénital malformatif -hernie congénitale
- ☐ Orifice acquis (rupture diaphragmatique)
- ☐ Orifice physiologique anormalement large (hernie hiatale)
Pas d'orifice anormal mais diaphragme flasque, hypoplasique

II Embryologie

La hernie diaphragmatique congénitale est une malformation précoce puisque le développement du diaphragme se produit entre 4 semaines et 8 semaines de la gestation on distingue

- Hernie diaphragmatique à travers le foramen d de Bochdalek= secondaire à un défaut de muscularisation du diaphragme situé entre les parties costales et lombaires (12^{em} cotes)
- Hernies diaphragmatiques par la fente de Larrey zone de faiblesse naturelle sur la partie antérieure du diaphragme entre les fibres musculaires du chef costal et chef sternal du diaphragme laissant passage à l'artère et la veine epigastriques superieures
- Hernies diaphragmatique acquise Passage à travers l'orifice hiatal d'une partie de l'estomac

III Diagnostic positif

1 Circonstances de découverte

- découverte fortuite
- détresse respiratoire Dyspnée, douleur thoracique pneumopathies, troubles digestifs (pyrosis regurgitation)

2 Examen clinique: pauvre

cyanose, tirage, polypnée
Thorax bombé Déviation du bruit du cœur

3 Radiologie:

Radiographie du thorax opacité: opacité homogène arrondie surmontant la coupole diaphragmatique

Scanner thoracique identifie la nature de la hernie

IRM (intéressante): montre la hernie et le défaut du diaphragme

معزوز عبد الكريم
أستاذ محاضر «أ»
جراحة عامة

IV Varietes d'hernies diaphragmatiques

Plusieurs variétés d'hernies diaphragmatiques

1 Hernies Hiatales

Désigne le passage de la partie supérieure de l'estomac dans le thorax à travers l'orifice hiatal du diaphragme

- Affection fréquente
- La plupart se développe avec l'âge et la fragilité des tissus
- Hernie par glissement/ par roulement/ mixtes
- Hernie par glissement: 85% des cas
 - augmente avec l'âge, la plus fréquente
 - Liée à une altération progressive des moyens de fixation du cardia à l'hiatus œsophagien, en particulier la membrane phrénéo-œsophagienne
- Hernie par roulement: 5%
 - L'estomac mais aussi (colon, épiploon, rate) peuvent être ascensionnés dans le thorax à travers l'orifice hiatal (large)
 - Danger : volvulus gastrique et conséquences ischémiques; Le volvulus gastrique aigu complication la plus grave des HH par roulement. Dans ce cas, la quasi-totalité de l'estomac peut se retrouver volvulée dans le thorax avec un risque majeur de nécrose ischémique et de perforation, et donc de médiastinite.
- Hernies hiatales mixtes 10%

Les hernies hiatales sont classées en différents types :

- * Type 1 : Hernies par glissement
 - * Type 2 : Hernies par roulement
 - * Type 3 : Hernies mixtes (par glissement et roulement)
 - * Type 4 : Hernies avec un autre organe abdominal ascensionné dans le médiastin
- Les hernies de type 1 n'ont pas de sac herniaire à la différence des types 2, 3, ou 4 qui possèdent un sac péritonéal herniaire.

2 Hernies congénitales antérieures

- ☐ Incidence : 1 et 6 % des hernies diaphragmatiques.
- ☐ La hernie de Morgani médiane soit la hernie de la fente de Larrey antérieure entre les faisceaux xiphoïdiens et les faisceaux d'insertion chondro-costaux reto xiphoïdienne

مؤيد عبد الكريم
أستاذ محاضر «أ»
جراحة عامة

- ☐ Le sac herniaire est quasi-constant avec un contenu essentiellement épiploïque et colique transverse, rarement (pancréatique/ hépatique)
- ☐ Habituellement découverte chez l'enfant devant un tableau aigu mais peuvent parfois passées inaperçues + diagnostiquée chez l'adulte.

- ❑ Souvent asymptomatiques (70-80%)/ découverte fortuite

3 Hernies congénitales posterolaterale

- Hernies congénitales /incidence 1cas/3200
- 60-90 % des cas des hernies congénitales
- (Associées à d'autre malformations abdominale, thoracique ou médiastinale dans 25 à 50 % des cas
- Prédominance à gauche 85%
- Découverte tardive à l'âge adulte est rare (5%)
- La présence d'un Hydramnios ou de malformations fœtales doivent faire systématiquement rechercher une hernie congénitale
- f. néonatale: pronostic vital mis en jeu en cas d'hypoplasie pulmonaire associée
- Diagnostic période anté-natale : échographie de dépistage (12 à 18 SA)

V Traitement

1 Objectif

Réduire la hernie et rétablir l'étanchéité du diaphragme

2 Moyens

chirurgicaux par laparotomie ou laparoscopie avec réduction de la hernie avec raphie du defect par suture ou mise en place d'une prothèse

3 Indications

a) En urgence

- nouveau né en cas de détresse respiratoire
- Quelque soit l'âge en cas de volvulus gastrique

b) Situation élective :

- hernie asymptomatique : abstention thérapeutique
- hernie symptomatique : traitement chirurgical

معزوز عبد الكريم
أستاذ محاضر «أ»
جراحة عامة